

ARBOVIROSES



ROTINA CLÍNICA

Modelos de prescrição

CHIKUNGUNYA

- **Uso oral:**

1) Dipirona 500 mg ---- 20 comprimidos

Tomar 1 a 2 comprimidos de 6/6h em caso de dor e/ou febre.

E/Ou

1) Paracetamol 500 mg ---- 20 comprimidos

Tomar 1 a 2 comprimidos de 6/6h em caso de dor e/ou febre (intercalar com dipirona se necessário).

2) Soro de reidratação oral ---- 5 sachês

Diluir conteúdo de 1 sachê em 1 litro de água filtrada e tomar ao longo do dia, por 5 dias. Conservar solução em geladeira.

Esta solução possui validade de 24 horas, descartar após esse período.



ROTINA CLÍNICA

CHIKUNGUNYA

- **Uso oral:**

3) Bromoprida 10 mg ---- 20 comprimidos
Tomar 1 comprimido de 8/8h em caso de náuseas e/ou vômitos.

Ou

3) Ondansetrona 4 mg ---- 20 comprimidos
Tomar 1 comprimido de 8/8h em caso de náuseas e/ou vômitos.

4) Loratadina 10 mg ---- 7 comprimidos
Tomar 1 comprimido uma vez ao dia em caso de prurido.

→ Priorizar uso à noite. Pode ser usado até de 12/12h em caso de prurido intenso.



CHIKUNGUNYA

- **Uso oral:**

4) Hidroxizina 25 mg -----30 comprimidos

Tomar 1 comprimido até de 6/6h em caso de prurido por até 10 dias.

Ou

4) Dexclorfeniramina 2 mg ---- 1 caixa

Tomar 1 comprimido de 8/8h em caso de prurido.

Se dor forte, associar tramadol (receita branca especial C1):

1) Cloridrato de tramadol 50 mg ---- 1 caixa

Tomar 1 comprimido de 8/8h em caso de dor forte e refratária à dipirona e/ou paracetamol.



CHIKUNGUNYA

- **Fase pós-aguda/crônica:**

Considerar fazer uso de corticoide oral.

Opção: prednisona 40 mg pela manhã, por 06 semanas, com redução progressiva da dose em 20% a cada 7 dias.

O ideal é que o paciente realize seguimento em UBS e, se possível, devemos encaminhar o paciente para avaliação com especialista (reumatologista) caso persistam sintomas articulares crônicos.



ROTINA CLÍNICA

ARBOVIROSES

- **Para TODAS as arboviroses, sempre devemos orientar sobre sinais de alarme:**
 - Dor abdominal intensa e contínua.
 - Vômitos persistentes.
 - Hipotensão postural ou lipotímia.
 - Sangramentos de mucosas.
 - Hemorragias importantes (hematêmese e/ou melena e enterorragia).
 - Sonolência ou irritabilidade.
 - Diminuição da diurese (diminuição do volume urinário).
 - Hipotermia.
 - Desconforto respiratório.
-
- **O paciente deve procurar atendimento médico imediatamente em caso de sinais de alarme.**



ARBOVIROSES

- Devemos também orientar sobre repouso, **hidratação adequada** (60 a 80 ml/kg/dia), sendo 1/3 de solução salina (SRO) e 2/3 de outros líquidos (água, suco de frutas, água de coco).
- O uso de **anti-inflamatórios** (Nimesulida, AAS, Ibuprofeno, Cetoprofeno, Diclofenaco, entre outros) é **CONTRAINDICADO!**



ZIKA

- Não há especificidades em relação à prescrição do paciente com suspeita de infecção aguda pelo Zika vírus.
- Utilize o mesmo modelo de receita apresentado para Chikungunya na fase aguda.
- Vale ressaltar que as orientações são as mesmas (sinais de alarme, repouso, hidratação e evitar AINES).



DENGUE

- **Grupos A e B* (tratamento ambulatorial)**

Nesses pacientes, a prescrição é similar à apresentada para os pacientes com Chikungunya na fase aguda.

Vale ressaltar que as orientações são as mesmas (sinais de alarme, repouso, hidratação e evitar AINES).



ROTINA CLÍNICA

DENGUE

- **Grupo B + ↑ hematócrito (> 44% nas mulheres e > 50% nos homens)**

Hidratação oral: 80 mL/kg, administrar 1/3 deste volume em 4 horas. Utilizar o soro de reidratação oral.

Ou

Hidratação parenteral: 40 mL/kg, utilizar SF 0,9% ou Ringer. Infundir em 04 horas.

Reavaliar clinicamente e solicitar novo hemograma após 04 horas:

↓ hematócrito e melhora clínica: Alta para tratamento ambulatorial (Grupo A).

Hematócrito persiste elevado ou sinal de alarme: internação (conduta do Grupo C).



DENGUE

- **Grupo C (internação e hidratação endovenosa imediata)**

Fase de expansão:

Solução cristalóide: 20 mL/kg em 01 hora.

Se houver melhora clínica sustentada, prescrever 1ª fase de manutenção com 25 ml/kg SF 0,9% em 6 horas.

Caso mantenha melhora clínica, prescrever 2ª fase. 25 ml/kg em 8 horas (1/3 do volume de solução fisiológica e 2/3 do volume de soro glicosado 5%).

Caso o paciente não apresente melhora, repetir a fase de expansão até 3 vezes. Se resposta inadequada, conduzir como dengue com sinais de choque (grupo D).



ROTINA CLÍNICA

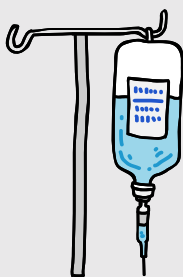
DENGUE

- **Grupo D (internação em UTI e hidratação endovenosa imediata)**

Solução cristaloide: 20 mL/kg em 20 minutos.
(Repetir esta fase até 3 vezes, se necessário).

Reavaliação clínica a cada 15 a 20 minutos e novo hematócrito em 2 horas!

Se melhora clínica e laboratorial, com resposta adequada, conduzir seguindo o algoritmo na fase de expansão do Grupo C (20 ml/kg em 01 hora).



DENGUE

- **Grupo D (internação em UTI e hidratação endovenosa imediata)**

Se resposta inadequada e hematócrito em elevação, considerar **albumina** (3 ml/kg/hora).

Se resposta inadequada e hematócrito em queda, considerar **transfusão de concentrado de hemácias, de plasma, vitamina K e crioprecipitados**.

